TAKILAN VAKAYI KURTAR™ · ANA MATERYAL

60 Takılan Vaka Senaryosu: Belirti → Olası Neden → Ne Yapmalı

Tedavinin ortasında ilerlemeyen vakalar için: belirtiyi tanıyın, nedenleri sırayla dışlayın, tek adımı seçin ve ne zaman yönlendireceğinizi bilin.

İçindekiler

Nasıl kullanılır: 5 adımlı takılma protokolü

60 senaryonun dizini

Bölüm 01 · Boşluk kapanmıyor

Bölüm 02 · Orta hat kapanmıyor

Bölüm 03 · Kapanış cevap vermiyor

Bölüm 04 · Ankraj kaybı

Bölüm 05 · Açık kapanış geri döndü

Bölüm 06 · Derin kapanış düzelmiyor

Bölüm 07 · Rotasyon nüksü

Bölüm 08 · Gömülü diş inmiyor

Bölüm 09 · Kök rezorpsiyonu şüphesi

Bölüm 10 · Elastik uyumsuzluğu

Bölüm 11 · Aparey sorunları

Bölüm 12 · Şeffaf plak oturmuyor

Bölüm 13 · Bitirmede kontaktlar ve kökler

Bölüm 14 · Transversal problemler

Bölüm 15 · Periodontal ve hijyen sorunları

BAŞLARKEN

Nasıl kullanılır

İki hasta arasında: belirtiyi bulun, kartı açın, sırayla uygulayın.

> *Takılan vaka, aynı ölçüm iki ardışık kontrolde değişmiyorsa ya da beklenmeyen yönde değişiyorsa takılmış sayılır. Bu kitapta her senaryo aynı yapıdadır.*

ALAN	NE İŞE YARAR
Belirti	Sandalyede gördüğünüz veya ölçtüğünüz şey.
Olası nedenler	En sık nedenden başlayarak sıralanmış 2–4 neden.
Kontrol edilecekler	Nedeni ayırt etmek için bakılacak noktalar. Kutucukları işaretleyin.
Ne yapmalı	Sırayla uygulanacak adımlar. Bir seferde tek değişken değiştirin.
Yönlendirme	Ne zaman başka bir disipline veya uzmana danışmalısınız.

5 adımlı takılma protokolü

1. **Ölçün.** Overjet, overbite, orta hat, boşluk ve ilişkiyi aynı referanslarla kaydedin.
2. **Belirtiyi adlandırın.** Dizinden ilgili senaryoyu bulun.
3. **Nedenleri sırayla dışlayın.** Önce uyum ve aparey bütünlüğü, sonra mekanik, en son biyoloji ve teşhis.
4. **Tek değişken değiştirin.** Aynı anda birden fazla şeyi değiştirirseniz neyin işe yaradığını bilemezsiniz.
5. **Kaydedin ve iki kontrol sonra yeniden ölçün.** İlerleme yoksa teşhis ve planı problem listesinden yeniden kurun.

Kırmızı bayraklar: önce durun, sonra düşünün

- Artan mobilite, renk değişikliği, kök kısalması şüphesi
- Hiç hareket etmeyen diş (ankiloz şüphesi)
- Dişeti çekilmesi, derin cep, iyileşmeyen yara
- TME ağrısı, kilitlenme, ağız açmada kısıtlılık

Bu bulgularda kuvveti artırmayın; değerlendirin, kaydedin ve gerekiyorsa yönlendirin.

Kuvvet ve doz hakkında

Bu kitap kuvvet değerleri ve ilaç dozu vermez. Kuvvet seçimi; dişe, köke, kemiğe ve hastaya göre hekimin klinik kararıdır.

DİZİN

60 senaryonun dizini

Belirtiyi bulun, numaraya gidin.

NO	SENARYO
B01	**Boşluk kapanmıyor**
01	Çekim boşluğu kontrolden kontrole aynı kalıyor
02	Kapanan boşluk zincir çıkınca tekrar açılıyor
03	Orta diastema kapanıp tekrar açılıyor
04	Boşluk kapanırken kesiciler aşırı dikleşti
05	Bir tarafta boşluk kapandı, diğer tarafta kapanmıyor
B02	**Orta hat kapanmıyor**
06	Dental orta hat mekaniğe rağmen düzelmiyor
07	Orta hat düzelirken bir taraf Sınıf II'ye kaydı
08	Orta hat düzeldi, sonra geri kaydı
09	Üst ve alt orta hat ters yönlerde sapmış
B03	**Kapanış cevap vermiyor**
10	Sınıf II elastiklere rağmen molar ilişki değişmiyor
11	Overjet azalıyor ama sadece alt kesiciler öne gidiyor
12	Fonksiyonel aparey sonrası Sınıf II çözülmüş gibi görünüyor ama ısırık iki konumlu
13	Sınıf III kamuflajda ters overjet kapanmıyor
14	Sınıf II düzeldi, aparey çıkınca overjet geri artıyor
B04	**Ankraj kaybı**
15	Üst molar mezialize oldu, overjet kapanmadan boşluk bitti
16	Mini vida mobil veya düştü
17	Seviyelemede alt kesiciler planlanandan fazla öne eğildi
18	Transpalatal bar veya Nance varken yine ankraj kaybı
B05	**Açık kapanış geri döndü**
19	Ön açık kapanış seviyelemede arttı
20	Açık kapanış kapandı, sonra yeniden açıldı
21	Lateral açık kapanış: premolarlarda temas yok
22	Elastik veya genişletme sonrası ön dişler açıldı
B06	**Derin kapanış düzelmiyor**

NO	SENARYO
23	Derin kapanış seviyelemeye rağmen açılmıyor
24	Üst kesiciler alt braketleri kırıyor
25	Derin kapanış düzeldi, bitirmede yeniden derinleşti
26	Diş eti gülüşüyle birlikte derin kapanış: üst kesici intrüzyonu ilerlemiyor
B07	**Rotasyon nüksü**
27	Rotasyon tel değiştikçe bile düzelmiyor
28	Rotasyon düzeldi, bir sonraki kontrolde geri döndü
29	Pekiştirme döneminde rotasyon nüksü
30	Rotasyon düzeltirken komşu kontakt açıldı
B08	**Gömülü diş inmiyor**
31	Gömülü kanin traksiyona cevap vermiyor
32	Traksiyon sırasında komşu kesicide mobilite
33	Yer açıldı ama premolar veya ikinci molar sürmüyor
34	Traksiyonla inen dişte dişeti problemi
B09	**Kök rezorpsiyonu şüphesi**
35	Kontrol panoramiğinde kesici kökleri kısa görünüyor
36	Tedavi sırasında dişte mobilite arttı
37	Travma öyküsü olan dişte renk değişikliği veya hassasiyet
B10	**Elastik uyumsuzluğu**
38	Hasta elastik takmıyor
39	Elastikler takılıyor ama yanlış konfigürasyonda
40	Elastik sürekli kopuyor veya hasta ağrı nedeniyle bırakıyor
41	Randevu kaçıran hasta: vakada kontrol kaybı
B11	**Aparey sorunları**
42	RME sonrası beklenen genişleme yok
43	Genişletme sonrası transversal nüks
44	Hareketli fonksiyonel apareyi hasta takmıyor
45	Sabit fonksiyonel aparey tekrar tekrar gevşiyor veya kırılıyor
46	Transpalatal bar veya Nance mukozaya gömülüyor
B12	**Şeffaf plak oturmuyor**
47	Plak dişin üzerine tam oturmuyor
48	Ataçman kopmuş veya aşınmış
49	Planlanan rotasyon veya ekstrüzyon gerçekleşmiyor
50	Plak kullanım süresi düşük
B13	**Bitirmede kontaktlar ve kökler**

NO	SENARYO
51	Kontaktlar açık kalıyor
52	Panoramikte kök paralelliği yok
53	Marjinal sırtlar seviyede değil
54	Posterior oklüzyon oturmuyor
B14	**Transversal problemler**
55	Posterior çapraz kapanış düzelmiyor
56	Makaslama kapanış düzelmiyor
57	Seviyelemede ark genişliği aşırı arttı
B15	**Periodontal ve hijyen sorunları**
58	Braket çevresinde beyaz lezyon başladı
59	Dişeti büyümesi mekaniği engelliyor
60	Alt kesici labialinde dişeti çekilmesi başladı

BÖLÜM 01

Boşluk kapanmıyor

Çekim boşluğu ve diastema: ölçü değişmiyor, geri açılıyor ya da yanlış dişler hareket ediyor.

Boşluk kapanmıyorsa önce mekaniği değil, kayma yolunu ve oklüzyonu kontrol edin. Çoğu zaman engel teldedir, kuvvette değil.

Sık hata

Seviyeleme tamamlanmadan boşluk kapamaya geçmek. Bükük bir tel üzerinde hiçbir diş düzgün kaymaz.

SENARYO 01

Çekim boşluğu kontrolden kontrole aynı kalıyor

Belirti: Elastik zincir veya kapama yayı aktif görünüyor ama boşluk ölçüsü iki-üç kontroldür değişmiyor.

OLASI NEDENLER

- Seviyeleme tamamlanmadan kapamaya geçilmiş; tel kayma yolunda bükülü veya rijit değil.
- Sürtünme: sıkı ligatür, braket kanadına takılan tel, tel üzerindeki büküm veya stop.
- Kuvvet kaybı: zincir uzun süredir değiştirilmemiş.
- Oklüzal engel: karşı arktaki diş kayan dişe temas ediyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Tel braket yuvalarına pasif oturuyor mu?
- [ ] Kayma yolunda büküm, stop veya krimp var mı?
- [ ] Zincir ya da yay en son ne zaman yenilendi?
- [ ] Kayan dişte erken oklüzal temas var mı?
- [ ] Boşluk bölgesinde dişeti ve kemik durumu?

NE YAPMALI

1. Seviyelemenin bittiğini doğrulayın; bitmediyse bir önceki tel aşamasına dönün.
2. Kayma yolunu temizleyin: büküm, stop ve kırık ligatürleri giderin.
3. Oklüzal engel varsa geçici ısırma yükseltmesi veya engel noktanın giderilmesini planlayın.
4. Aktivasyonu yenileyin, kontrol aralığını kısa tutun.
5. İki kontrol sonra aynı referans noktalarından yeniden ölçün ve kaydedin.

Ne zaman yönlendirmeli: Boşluk bölgesinde derin cep, kemik defekti veya dişeti çekilmesi görürseniz periodontoloji görüşü alın. Kök kortikal kemiğe dayanıyor şüphesi varsa ileri görüntüleme açısından değerlendirin.

SENARYO 02

Kapanan boşluk zincir çıkınca tekrar açılıyor

Belirti: Kontrolde kapalı görünen boşluk, bir sonraki kontrolde yeniden açılmış.

OLASI NEDENLER

- Dişler kapandıktan sonra birbirine bağlanmamış (pasif bağlama yok).
- Kökler paralel değil; sadece kuronlar devrilerek kapanmış.
- Dil itimi veya dudak alışkanlığı.
- Kapanış sırasında aşırı kuvvet ve hızlı hareket.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Panoramikte kök paralelliği
- [ ] Kapanan dişler arasında bağlantı var mı?
- [ ] Dil pozisyonu ve yutkunma paterni
- [ ] Tel boyutu tork ve kök kontrolüne yetiyor mu?

NE YAPMALI

1. Kapanan segmenti pasif olarak bağlayın.
2. Kök paralelliğini değerlendirin; gerekiyorsa braket pozisyonunu düzeltin ve kök hareketine zaman tanıyın.
3. Kapanışı daha rijit bir tel üzerinde ve kontrollü sürdürün.
4. Alışkanlık varsa hastaya açıklayın ve kaydedin.
5. Bitirmeden önce pekiştirme planını bu bölgeye göre güncelleyin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Dil itimi belirgin ve yutkunma bozukluğu eşlik ediyorsa miyofonksiyonel değerlendirme için ilgili uzmana yönlendirin.

SENARYO 03 Orta diastema kapanıp tekrar açılıyor

Belirti: Üst orta kesiciler arasındaki boşluk kapanıyor, birkaç hafta sonra yine açılıyor.

OLASI NEDENLER

- Kalın veya düşük yapışan labial frenulum.
- Bolton uyumsuzluğu: üst kesiciler göreceli olarak küçük.
- Periodontal destek kaybı veya kesici proklinasyonu.
- Orta hatta fazla sayılı diş veya patoloji.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Frenulum çekme testi: papilla beyazlıyor mu?
- [ ] Bolton analizi yapıldı mı?
- [ ] Orta hat bölgesinin radyografisi
- [ ] Kesici eğimi ve overjet
- [ ] Periodontal sondalama

NE YAPMALI

1. Radyografik olarak orta hat patolojisini ve fazla sayılı dişi dışlayın.
2. Bolton analizini yapın; diş boyutu uyumsuzluğunu planlamaya ekleyin.
3. Boşluğu kapatıp kesicileri pasif olarak bağlayın.
4. Frenulum şüphesinde zamanlamayı ilgili hekimle birlikte planlayın.
5. Pekiştirme planına sabit lingual pekiştirmeyi değerlendirin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Frenulum için cerrahi değerlendirme, fazla sayılı diş veya kist şüphesi için ağız, diş ve çene cerrahisi; periodontal destek kaybında periodontoloji.

SENARYO 04 Boşluk kapanırken kesiciler aşırı dikleşti

Belirti: Boşluk kapanıyor ama üst kesiciler retrüze ve dik; overbite derinleşiyor, gülüş düzleşiyor.

OLASI NEDENLER

- Tel yuvayı doldurmuyor; tork kontrolü yok.
- Ön segment geri çekilirken retraksiyon kuvveti kök kontrolü olmadan uygulanmış.
- Maksimum ankraj planlanmış ama ön dişler planlanandan fazla hareket etmiş.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Kesici eğimi: başlangıç ve şimdiki değer (U1-SN)
- [ ] Kullanılan tel boyutu ve materyali
- [ ] Overbite değişimi
- [ ] Gülüşte kesici görünürlüğü

NE YAPMALI

1. Retraksiyonu durdurun ve torku yeniden kazanın.
2. Yuvayı daha iyi dolduran tel ve gerekiyorsa tel üzerinde tork bükümü kullanın.
3. Kalan boşluğu kök kontrolü sağlandıktan sonra kapatın.
4. Derinleşen kapanışı eş zamanlı yönetin (bkz. Bölüm 06).
5. Sefalometrik kontrolle ilerlemeyi belgeleyin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Kök yüzeyinin kortikal kemiğe dayandığından şüpheleniyorsanız ileri görüntüleme ve deneyimli bir ortodontist görüşü alın.

SENARYO 05

Bir tarafta boşluk kapandı, diğer tarafta kapanmıyor

Belirti: Sağ ve sol çekim boşlukları farklı hızda kapanıyor; orta hat kaymaya başlıyor.

OLASI NEDENLER

- İki tarafta farklı sürtünme veya farklı aktivasyon.
- Bir tarafta oklüzal engel veya çapraz kapanış.
- Kemik yoğunluğu ya da kök morfolojisi farkı.
- Ankraj iki tarafta eşit planlanmamış.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Her iki taraftaki aktivasyon ve zincir uzunluğu
- [ ] Taraflara göre oklüzal temaslar
- [ ] Orta hat başlangıca göre nerede?
- [ ] Panoramikte kök morfolojisi ve kemik

NE YAPMALI

1. Kapanan tarafı pasif bağlayın, kapanmayan tarafa odaklanın.
2. Kapanmayan taraftaki engeli giderin (bkz. Senaryo 01 kontrolleri).
3. Gerekiyorsa tek taraflı ek ankraj planlayın.
4. Orta hattı her kontrolde aynı referansla kaydedin.
5. Asimetri sürerse planı problem listesinden yeniden kurun.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Ankiloz şüphesi (metalik perküsyon sesi, dişin hiç hareket etmemesi) varsa Rehber 4 · Travma ve Ankiloz bölümüne bakın ve gerekiyorsa uzman görüşü alın.

BÖLÜM 02

Orta hat kapanmıyor

Dental orta hat sapması mekaniğe cevap vermiyor, düzelirken kapanış bozuluyor ya da geri kayıyor.

Orta hat sapmasında ilk soru şudur: sapma dental mi, iskeletsel mi, fonksiyonel mi? Yanlış soruya mekanikle cevap verilmez.

Sık hata

Sapmanın hangi arkta olduğunu yüz orta hattına göre değil, sadece dişlere bakarak belirlemek.

SENARYO 06

Dental orta hat mekaniğe rağmen düzelmiyor

Belirti: Asimetrik mekanik uygulanmasına rağmen orta hat aylardır aynı yerde.

OLASI NEDENLER

- Sapma iskeletsel (mandibular asimetri), mekanik dental düzeyde kalıyor.
- Fonksiyonel kayma: erken temas nedeniyle mandibula yana kayıyor.
- Sapma kaynağı yanlış arkta tespit edilmiş.
- Bir tarafta boşluk yok; hareket için yer kalmamış.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Yüz orta hattına göre üst ve alt dental orta hat
- [ ] Açık ağız ve sentrik ilişkide orta hat
- [ ] Erken temas noktası
- [ ] Taraflara göre yer analizi

NE YAPMALI

1. Hastayı sentrik ilişkide yeniden değerlendirin.
2. Fonksiyonel kayma varsa önce erken teması ve transversal problemi çözün.
3. Sapmanın hangi arkta olduğunu yeniden belirleyin ve mekaniği o arka yönlendirin.
4. Hareket için gereken yeri hesaplayın (IPR, boşluk, çekim planı).
5. İskeletsel asimetri varsa hedefi kamuflaj sınırları içinde yeniden tanımlayın.

Ne zaman yönlendirmeli: Belirgin iskeletsel asimetri, çene ucu sapması veya TME bulgusu varsa ağız, diş ve çene cerrahisi ile ortak değerlendirme yapın.

SENARYO 07 Orta hat düzelirken bir taraf Sınıf II'ye kaydı

Belirti: Orta hat düzeliyor ama elastik uygulanan tarafta kanin ve molar ilişkisi bozuluyor.

OLASI NEDENLER

- Tek taraflı elastik, karşı tarafta istenmeyen hareket yaratıyor.
- Ankraj tek tarafta zayıf.
- Orta hat sapması aslında sagital asimetriden kaynaklanıyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Taraf taraf kanin ve molar ilişkisi
- [ ] Elastik konfigürasyonu ve süresi
- [ ] Ankraj planı
- [ ] Ark formu simetrik mi?

NE YAPMALI

1. Kanin ilişkisini öncelik yapın; orta hattı tek başına hedef almayın.
2. Elastiği bozulan ilişkiyi düzeltecek yönde yeniden planlayın.
3. Gerekirse tek taraflı ek ankraj kullanın.
4. Ark formunun simetrisini bir şablonla kontrol edin.
5. Her kontrolde taraf taraf ilişkiyi kaydedin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Sagital asimetri iskeletselse ve kamuflaj yüzü olumsuz etkileyecekse cerrahi ile ortak planlama düşünün.

SENARYO 08 Orta hat düzeldi, sonra geri kaydı

Belirti: Bir önceki kontrolde orta hatlar çakışıktı, şimdi yeniden sapmış.

OLASI NEDENLER

- Elastik bırakılınca dişler eski konumlarına dönüyor.
- Kökler hareket etmemiş, kuronlar devrilmiş.
- Erken temas veya çapraz kapanış devam ediyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Panoramikte kök angulasyonları
- [ ] Oklüzal temaslar ve kayma
- [ ] Hasta elastiği nasıl bıraktı?

NE YAPMALI

1. Kök angulasyonlarını düzeltin; gerekirse braketi yeniden konumlayın.
2. Elastiği aniden değil, kademeli bırakın.
3. Oklüzal temasları dengeleyin.
4. Düzelmeyi birkaç kontrol boyunca koruyun ve kaydedin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Kayma TME semptomlarıyla birlikteyse TME değerlendirmesi için ilgili uzmana yönlendirin.

SENARYO 09

Üst ve alt orta hat ters yönlerde sapmış

Belirti: Bir orta hat sağa, diğeri sola kaymış; birini düzeltmek diğerini bozuyor.

OLASI NEDENLER

- Diş boyutu uyumsuzluğu (Bolton).
- Eksik, küçük veya fazla sayılı diş.
- Asimetrik çekim veya asimetrik çapraşıklık.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Bolton analizi
- [ ] Eksik veya küçük diş
- [ ] Taraflara göre çapraşıklık
- [ ] Yüz orta hattı

NE YAPMALI

1. Her iki arkın sapmasını yüz orta hattına göre ayrı ayrı ölçün.
2. Diş boyutu uyumsuzluğunu IPR veya restoratif planla birlikte değerlendirin.
3. Önce daha büyük sapan arkı düzeltin.
4. Kalan farkı bitirmede kabul edilebilir sınırda bırakmayı hastayla konuşun.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Küçük veya eksik dişlerin restorasyonu gerekiyorsa restoratif diş tedavisi ile ortak plan yapın.

BÖLÜM 03

Kapanış cevap vermiyor

Sınıf II ve Sınıf III düzeltmesi beklenen yanıtı vermiyor ya da yanıt sadece dişlerde kalıyor.

Sagital düzeltme ilerlemiyorsa sırayla bakın: uyum, mekanik, büyüme, teşhis. Çoğu takılma ilk ikisindedir.

Sık hata

Molar ilişkiye bakıp kanin ilişkisini ve kesici eğimini kaydetmemek.

SENARYO 10

Sınıf II elastiklere rağmen molar ilişki değişmiyor

Belirti: Hasta elastik kullandığını söylüyor; molar ve kanin ilişkisi aylardır aynı.

OLASI NEDENLER

- Hasta elastiği yeterli süre kullanmıyor.
- Ark telleri elastiğe dayanacak rijitlikte değil.
- Üst arkta kalan boşluk veya ankraj yetersiz.
- Problem iskeletsel ve dental kamuflaj sınırında.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Elastik aşınması, tutucu kancalar ve hastanın anlatımı
- [ ] Tel boyutu ve materyali
- [ ] Overjet ve kanin ilişkisi (mm)
- [ ] Büyüme dönemi

NE YAPMALI

1. Uyumu hastayla açıkça konuşun ve bir kullanım takvimi verin.
2. Elastikleri rijit teller üzerinde kullanın.
3. Ankrajı yeniden değerlendirin; gerekirse ek ankraj planlayın.
4. İki kontrol sonra ölçün; ilerleme yoksa teşhisi yeniden kurun.

Ne zaman yönlendirmeli: İskeletsel uyumsuzluk kamuflaj sınırını aşıyorsa ortognatik cerrahi açısından cerrahi ile ortak değerlendirme yapın.

SENARYO 11

Overjet azalıyor ama sadece alt kesiciler öne gidiyor

Belirti: Overjet düzeliyor, molar ilişki değişmiyor; alt kesiciler protrüze görünüyor.

OLASI NEDENLER

- Elastik etkisi alt arkta kesicilerde toplanıyor.
- Alt arkta ankraj yetersiz.
- Alt kesici eğimi baştan zaten artmış.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] IMPA başlangıç ve şimdiki değer
- [ ] Alt kesici labialinde dişeti ve kemik
- [ ] Alt arkta tork kontrolü

NE YAPMALI

1. Alt kesici eğimini kontrol altına alın; tork kontrollü tel kullanın.
2. Alt arkta ankrajı güçlendirin.
3. Elastik planını gözden geçirin.
4. Kesici eğimi sınırına geldiyse kamuflaj hedefini yeniden konuşun.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Alt kesici labialinde dişeti incelmesi veya çekilme başladıysa periodontoloji görüşü alın.

SENARYO 12

Fonksiyonel aparey sonrası Sınıf II çözülmüş gibi görünüyor ama ısırık iki konumlu

Belirti: Hasta öne kaydırarak ısırınca Sınıf I, rahat konumda Sınıf II; çift ısırık şüphesi.

OLASI NEDENLER

- Mandibula iskeletsel olarak değil, postüral olarak önde tutuluyor.
- Kondil konumu stabil değil.
- Değerlendirme sentrik ilişkide yapılmamış.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Sentrik ilişkide ve rahat kapanışta overjet
- [ ] Kas palpasyonu ve TME bulguları
- [ ] Sefalometride ANB değişimi

NE YAPMALI

1. Sentrik ilişkide yeniden kayıt alın.
2. Gerçek düzelme ile postüral düzelmeyi ayırın ve kaydedin.
3. Sabit aşamaya geçmeden ilişkinin stabil olduğunu doğrulayın.
4. Gerekirse fonksiyonel aşamayı uzatın veya planı yeniden kurun.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** TME ağrısı, kilitlenme veya belirgin ses varsa TME değerlendirmesi için ilgili uzmana yönlendirin.

SENARYO 13 Sınıf III kamuflajda ters overjet kapanmıyor

Belirti: Ön çapraz kapanış devam ediyor; kesiciler planlanandan fazla eğilmiş.

OLASI NEDENLER

- Problem iskeletsel ve kamuflaj sınırında.
- Hasta büyümeye devam ediyor.
- Fonksiyonel öne kayma mevcut ve değerlendirilmemiş.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Sentrik ilişkide kesici kenar ilişkisi
- [ ] Üst ve alt kesici eğimleri
- [ ] Büyüme durumu ve aile öyküsü
- [ ] Profil değişimi

NE YAPMALI

1. Fonksiyonel kayma var mı ayırt edin.
2. Kesici eğim sınırını belirleyin ve aşmayın.
3. Büyüme devam ediyorsa planı büyümeye göre güncelleyin.
4. Kamuflaj yetmiyorsa hasta ve aileyle seçenekleri yeniden konuşun.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Sınıf III iskeletsel ve büyüme sürüyorsa ya da kamuflaj sınırı aşıldıysa cerrahi ile ortak planlama yapın.

SENARYO 14 Sınıf II düzeldi, aparey çıkınca overjet geri artıyor

Belirti: Aparey sonrası kontrollerde overjet kademeli olarak artıyor.

OLASI NEDENLER

- Düzelme dental kompanzasyonla olmuş.
- Büyüme paterni olumsuz devam ediyor.
- Geçiş döneminde tutucu aparey kullanılmamış.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Overjet ve molar ilişki seri ölçümleri
- [ ] Dudak kapanışı ve alışkanlık
- [ ] Geçiş planı

NE YAPMALI

1. Geçiş dönemi için tutucu planlayın.
2. Overjet değişimini her kontrolde kaydedin.
3. Sabit aşamada Sınıf II mekaniğini plana ekleyin.
4. Planlanan hedefi hastayla yeniden konuşun.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Belirgin iskeletsel nüks varsa deneyimli bir ortodontistle ortak değerlendirme yapın.

BÖLÜM 04

Ankraj kaybı

Ankraj dişleri planlanandan fazla hareket etti; boşluk tükendi veya kesiciler istenmeyen yöne gitti.

Ankraj kaybı fark edildiğinde hemen ölçün ve kalan boşluğu yeniden hesaplayın. Gecikme, seçenekleri azaltır.

Sık hata

Ankraj ihtiyacını tedavi başında yazmamak; sonra neyin kaybedildiğini bilmemek.

SENARYO 15

Üst molar mezialize oldu, overjet kapanmadan boşluk bitti

Belirti: Çekim boşluğu kapandı ama overjet hâlâ fazla; molar ilişki Sınıf II'ye kaymış.

OLASI NEDENLER

- Maksimum ankraj gerekirken orta düzey ankraj planlanmış.
- Seviyeleme sırasında molarlar öne devrilmiş.
- Ön dişler kök kontrolüyle geri çekilmemiş.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Başlangıç ve şimdiki molar ilişkisi
- [ ] Kalan overjet (mm)
- [ ] Molar angulasyonu
- [ ] Ankraj planı kaydı

NE YAPMALI

1. Kalan boşluk ve overjet ihtiyacını hesaplayın.
2. Ek ankraj seçeneğini planlayın (mini vida, Sınıf II mekaniği).
3. Gerekiyorsa molarları distale konumlayan mekaniği değerlendirin.
4. Hedefi ve süreyi hastayla yeniden konuşun.

Ne zaman yönlendirmeli: Mini vida planlanıyor ve anatomik sınır şüphesi varsa ileri görüntüleme ve deneyimli bir hekim görüşü alın.

SENARYO 16 Mini vida mobil veya düştü

Belirti: Kontrolde mini vida hareketli ya da hasta vidanın düştüğünü söylüyor.

OLASI NEDENLER

- Yumuşak dokunun hareketli olduğu bölgeye yerleşim.
- Köke yakınlık.
- Çevre doku iltihabı ve yetersiz hijyen.
- Yerleştirme sonrası erken ve fazla yükleme.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Vida çevresinde iltihap
- [ ] Komşu köklere uzaklık
- [ ] Yüklemenin ne zaman başladığı
- [ ] Hasta temizliği

NE YAPMALI

1. Mobil vidayı yüklemeyin; çıkarma kararını verin.
2. Bölgeyi temizleyin ve iyileşmeyi kontrol edin.
3. Yeni yerleşim bölgesini köke uzaklık ve dokuya göre seçin.
4. Mekaniği vida yokken ankraj kaybını sınırlayacak şekilde ayarlayın.
5. Olayı ve olası nedeni günlüğe kaydedin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Vida çevresinde yayılan enfeksiyon, ağrı veya kök hasarı şüphesinde ağız, diş ve çene cerrahisi değerlendirmesi.

SENARYO 17 Seviyelemede alt kesiciler planlanandan fazla öne eğildi

Belirti: Çapraşıklık çözülüyor ama alt kesiciler protrüze; dudak profili öne gelmiş.

OLASI NEDENLER

- Yer ihtiyacı kesici proklinasyonu ile karşılanmış.
- Planlanan IPR veya çekim yapılmamış.
- Ark formu genişletilmiş.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] IMPA başlangıç ve şimdiki değer
- [ ] Yer analizi yeniden
- [ ] Labial dişeti kalınlığı
- [ ] Profil değişimi

NE YAPMALI

1. Yer analizini yeniden yapın.
2. IPR veya çekim seçeneğini yeniden değerlendirin.
3. Ark formunu başlangıç formuna yaklaştırın.
4. Kesici eğimini tork kontrollü tel ile yönetin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Labial dişeti incelmesi veya çekilme belirtisi varsa periodontoloji görüşü alın.

SENARYO 18

Transpalatal bar veya Nance varken yine ankraj kaybı

Belirti: Ankraj apareyi yerinde ama molarlar öne gelmiş.

OLASI NEDENLER

- Bant gevşemiş, aparey pasif kalmış.
- Aparey ankraj ihtiyacına göre yetersiz.
- Ön dişlere uygulanan kuvvet planlanandan fazla.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Bantların oturması ve simanı
- [ ] Apareyin dokuya uyumu
- [ ] Molar ilişki seri ölçümleri

NE YAPMALI

1. Bantları ve aparey bağlantısını kontrol edin; gerekirse yenileyin.
2. Ankraj ihtiyacını yeniden belirleyin; ek ankraj gerekiyor mu karar verin.
3. Ön segmente uygulanan kuvveti azaltın.
4. Kalan boşluğu yeniden hesaplayın.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Damak mukozasında ülser veya doku gömülmesi varsa önce dokuyu iyileştirin; iyileşmeyen lezyonda ilgili uzmana yönlendirin.

BÖLÜM 05

Açık kapanış geri döndü

Ön veya lateral açık kapanış kapanmıyor, artıyor ya da kapandıktan sonra yeniden açılıyor.

Açık kapanışta mekanikten önce nedeni arayın: alışkanlık, dil, solunum, büyüme paterni. Neden durmuyorsa açık kapanış geri gelir.

Sık hata

Açık kapanışı sadece dişleri uzatarak kapatmak ve nedeni kayda geçirmemek.

SENARYO 19

Ön açık kapanış seviyelemede arttı

Belirti: Seviyeleme ilerledikçe ön açıklık büyüdü.

OLASI NEDENLER

- Posterior dişler ekstrüze oldu, mandibula aşağı-geri döndü.
- Spee eğrisi düzleşirken ön dişler intrüze oldu.
- Dil itimi veya parmak emme devam ediyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Overbite seri ölçümleri
- [ ] FMA ve dik yön paterni
- [ ] Dil pozisyonu
- [ ] Alışkanlık öyküsü

NE YAPMALI

1. Posterior ekstrüzyonu artıran mekaniği durdurun.
2. Ark tellerini dik yön kontrolüne göre seçin.
3. Alışkanlığı hastayla ve aileyle konuşun.
4. Dik yön kontrolü için ek seçenekleri değerlendirin (bkz. Modül 06).

Ne zaman yönlendirmeli: Ağız solunumu veya adenoid şüphesinde kulak burun boğaz değerlendirmesi; dil itiminde miyofonksiyonel değerlendirme.

SENARYO 20

Açık kapanış kapandı, sonra yeniden açıldı

Belirti: Bitirmede overbite pozitifti; kontrollerde azalarak sıfıra indi.

OLASI NEDENLER

- Dil itimi tedavi edilmeden mekanikle kapatılmış.
- Kapanış sadece kesici ekstrüzyonuyla sağlanmış.
- Büyüme dik yönde devam ediyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Dil pozisyonu ve yutkunma
- [ ] Kesici kronlarının görünürlüğü
- [ ] Sefalometride dik yön değişimi

NE YAPMALI

1. Nüksün miktarını ölçün ve kaydedin.
2. Nedeni belirleyin; alışkanlık sürüyorsa önce onu ele alın.
3. Pekiştirme planını dik yön kontrolünü içerecek şekilde güncelleyin.
4. Yeniden tedavi gerekiyorsa hedefi gerçekçi tanımlayın.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Belirgin iskeletsel açık kapanışta cerrahi ile ortak değerlendirme; dil ve solunum problemlerinde ilgili uzman.

SENARYO 21

Lateral açık kapanış: premolarlarda temas yok

Belirti: Ön ve molar temas var; premolar bölgesinde dişler temas etmiyor.

OLASI NEDENLER

- Braket yüksekliği hatası.
- Yanakta veya dilde dişler arasına giren yumuşak doku.
- Sürme bozukluğu veya ankiloz.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Braket yükseklikleri
- [ ] Lateral dil itimi
- [ ] Panoramikte kök ve kemik seviyesi
- [ ] Perküsyon sesi

NE YAPMALI

1. Braket yüksekliklerini kontrol edin; gerekiyorsa yeniden konumlayın.
2. Ankiloz şüphesini dışlayın.
3. Bitirmede hafif oturtma mekaniği planlayın.
4. Dil pozisyonunu kaydedin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Ankiloz şüphesinde Rehber 4 · Travma ve Ankiloz bölümüne bakın ve gerekirse uzman görüşü alın.

SENARYO 22

Elastik veya genişletme sonrası ön dişler açıldı

Belirti: Sınıf II elastik veya transversal genişletme sonrası overbite azaldı.

OLASI NEDENLER

- Elastik posterior dişleri ekstrüze etti.
- Genişletme ile posterior tüberküller düştü.
- Hasta yüksek açılı dik yön paterninde.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] FMA ve dik yön paterni
- [ ] Molar ve premolar ekstrüzyonu
- [ ] Elastik yönü ve süresi

NE YAPMALI

1. Elastik konfigürasyonunu dik yöne göre yeniden planlayın.
2. Posterior oklüzal temasları kontrol edin.
3. Gerekirse dik yön kontrolü için ek ankraj seçeneklerini değerlendirin.
4. Overbite değişimini her kontrolde kaydedin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Dik yön problemi iskeletsel ve ilerleyiciyse deneyimli bir ortodontistle ortak değerlendirme yapın.

BÖLÜM 06

Derin kapanış düzelmiyor

Overbite azalmıyor, alt braketlere kapanış var ya da bitirmede kapanış yeniden derinleşiyor.

Derin kapanışta önce hangi dişin hareket etmesi gerektiğine karar verin: üst kesici, alt kesici veya posterior dişler. Gülüş ve dik yön paterni bu kararı belirler.

Sık hata

Her derin kapanışı aynı mekanikle açmaya çalışmak; gülüşte kesici görünürlüğünü kaydetmemek.

SENARYO 23

Derin kapanış seviyelemeye rağmen açılmıyor

Belirti: Teller ilerledi ama overbite neredeyse aynı.

OLASI NEDENLER

- Spee eğrisi derin; ark teli eğriyi düzleştirmiyor.
- Alt braketler kesicilerin açılmasına izin vermeyecek konumda.
- Kesiciler dik; tork eksikliği kapanışı derinleştiriyor.
- Hasta düşük açılı, güçlü kas paterninde.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Spee eğrisi derinliği
- [ ] Kesici eğimleri
- [ ] Braket yükseklikleri
- [ ] FMA ve kas paterni

NE YAPMALI

1. Hangi dişin intrüzyonu veya ekstrüzyonunun gerektiğini yazın.
2. Spee eğrisini kontrollü düzleştirecek tel sırasını planlayın.
3. Kesici torkunu düzeltin; dik kesiciler kapanışı derinleştirir.
4. Gerekirse ön ısırma düzlemi veya ek ankraj seçeneklerini değerlendirin.

Ne zaman yönlendirmeli: Derin kapanışa TME ağrısı veya dişeti travması eşlik ediyorsa ilgili uzman değerlendirmesi.

SENARYO 24 Üst kesiciler alt braketleri kırıyor

Belirti: Alt kesici braketleri tekrar tekrar düşüyor; hasta braketlere ısırdığını söylüyor.

OLASI NEDENLER

- Alt braketler kapanış yolunda.
- Overbite açılmadan alt kesicilere braket yapıştırılmış.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Kapanışta braket teması
- [ ] Braket aşınma izleri
- [ ] Overbite (mm)

NE YAPMALI

1. Geçici ısırma yükseltmesi planlayın.
2. Gerekirse alt braket yapıştırmasını overbite azalana kadar erteleyin.
3. Overbite açıldıktan sonra braketleri doğru yükseklikte yapıştırın.
4. Hastaya sert gıdalar konusunda bilgi verin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Kesici kenarlarında çatlak veya kırık varsa restoratif diş tedavisi değerlendirmesi.

SENARYO 25 Derin kapanış düzeldi, bitirmede yeniden derinleşti

Belirti: Orta aşamada overbite normaldi; bitirme kontrollerinde arttı.

OLASI NEDENLER

- Boşluk kapama sırasında kesiciler dikleşti.
- Rijit telden esnek tele dönülürken kontrol kaybedildi.
- Interinsizal açı arttı.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Kesici eğimleri
- [ ] Overbite seri ölçümleri
- [ ] Tel sırası

NE YAPMALI

1. Kesici torkunu yeniden kazanın.
2. Bitirmede dik yön kontrolünü koruyacak tel kullanın.
3. Pekiştirme planına ön dişlerin kontrolünü ekleyin.
4. Değişimi kaydedin ve bir sonraki vakada boşluk kapama torkunu izleyin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Nüks hızlı ve belirgin ise deneyimli bir ortodontistle değerlendirin.

SENARYO 26

Diş eti gülüşüyle birlikte derin kapanış: üst kesici intrüzyonu ilerlemiyor

Belirti: Gülüşte fazla dişeti görünüyor; üst kesiciler intrüze olmuyor.

OLASI NEDENLER

- İntrüzyon mekaniği posterior dişlerde ekstrüzyon yaratıyor.
- Kesiciler dik; kuvvet yönü intrüzyona uygun değil.
- Dişeti görünümünün nedeni dental değil (dudak, kemik, dişeti).

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Gülüşte kesici ve dişeti görünürlüğü
- [ ] Dudak uzunluğu ve hareketliliği
- [ ] Kesici kron boyu
- [ ] Posterior ekstrüzyon

NE YAPMALI

1. Dişeti görünümünün nedenini ayırın: dental, iskeletsel, yumuşak doku.
2. İntrüzyon için ek ankraj seçeneğini değerlendirin.
3. Kesici eğimini intrüzyondan önce düzeltin.
4. Gerçekçi hedefi hastayla konuşun.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Kısa klinik kron veya dişeti fazlalığı varsa periodontoloji; iskeletsel dik yön fazlalığında cerrahi ile ortak değerlendirme.

BÖLÜM 07

Rotasyon nüksü

Rotasyon düzelmiyor, düzeldikten sonra geri dönüyor ya da pekiştirmede nüks ediyor.

Rotasyon en sık nükseden harekettir. Düzeltmeyi erken yapın, aşırı düzeltmeyi planlayın ve kontrol aşamasında koruyun.

Sık hata

Rotasyonu düzeltip pekiştirme planına bu dişi özel olarak yazmamak.

SENARYO 27

Rotasyon tel değiştikçe bile düzelmiyor

Belirti: Rotasyonlu diş birkaç tel aşamasından sonra aynı konumda.

OLASI NEDENLER

- Tel braket yuvasına tam oturmuyor (ligatür gevşek).
- Rotasyon için yer yok.
- Braket diş üzerinde merkezde değil.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Telin yuvaya oturması
- [ ] Komşu kontaktlarda yer
- [ ] Braketin mezyodistal konumu

NE YAPMALI

1. Telin yuvaya tam bağlandığından emin olun.
2. Rotasyon için gereken yeri açın.
3. Braket konumu hatalıysa yeniden yapıştırın.
4. Gerekiyorsa rotasyon yardımcısı ekleyin ve kontrol aralığını kısaltın.

Ne zaman yönlendirmeli: Diş hiç hareket etmiyorsa ankiloz açısından değerlendirin (Rehber 4).

SENARYO 28 Rotasyon düzeldi, bir sonraki kontrolde geri döndü

Belirti: Önceki kontrolde düzgün olan diş yeniden dönmüş.

OLASI NEDENLER

- Ligatür kopmuş veya gevşemiş.
- Daha esnek tele geçilmiş.
- Periodontal lifler eski konuma çekiyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Ligatür sağlamlığı
- [ ] Kullanılan tel
- [ ] Hastanın bildirdiği kırık parça

NE YAPMALI

1. Ligatürü sağlamlaştırın.
2. Rijit telde birkaç kontrol boyunca koruyun.
3. Aşırı düzeltmeyi planlayın.
4. Pekiştirme planında bu dişi özel olarak not edin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Rotasyonlu dişte belirgin dişeti problemi varsa periodontoloji görüşü.

SENARYO 29 Pekiştirme döneminde rotasyon nüksü

Belirti: Tedavi bitti; birkaç ay sonra başlangıçta rotasyonlu olan diş dönmüş.

OLASI NEDENLER

- Pekiştirme apareyi düzenli kullanılmamış.
- Sabit lingual pekiştirme kopmuş veya bu dişi kapsamıyor.
- Aşırı düzeltme yapılmamış.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Pekiştirme apareyi sağlam mı ve uyuyor mu?
- [ ] Sabit pekiştirmenin kapsadığı dişler
- [ ] Nüks miktarı

NE YAPMALI

1. Nüksü ölçün ve kaydedin.
2. Apareyi yenileyin veya onarın.
3. Hafif nükste pekiştirme ile kontrol; belirgin nükste yeniden tedavi seçeneklerini konuşun.
4. Rehber 2 · Ortodontik Pekiştirme El Kitabı'ndaki planı gözden geçirin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Nüks periodontal destek kaybıyla birlikteyse periodontoloji görüşü.

SENARYO 30

Rotasyon düzeltirken komşu kontakt açıldı

Belirti: Döndürülen dişin yanında küçük bir boşluk oluştu veya komşu diş kaydı.

OLASI NEDENLER

- Rotasyon için kullanılan kuvvet komşu dişe aktarılmış.
- Diş genişliği rotasyonla değişti (mezyodistal ölçü).

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Kontakt noktaları
- [ ] Komşu dişin konumu
- [ ] Kalan boşluk miktarı

NE YAPMALI

1. Segmenti pasif bağlayın.
2. Açılan boşluğu kontrollü kapatın.
3. Bitirme öncesi kontakt kontrolünü listeye ekleyin.

Ne zaman yönlendirmeli: Kontakt açıklığı restoratif şekil farkından kaynaklanıyorsa restoratif diş tedavisi.

BÖLÜM 08

Gömülü diş inmiyor

Traksiyona rağmen gömülü diş hareket etmiyor, komşu dişte sorun başladı ya da yer açıldığı halde diş sürmüyor.

Gömülü dişte en önemli kontrol, dişin hangi yöne ve ne kadar hareket ettiğini seri olarak kaydetmektir. Hareket yoksa nedeni hemen araştırın.

Sık hata

Hareket etmeyen dişe kuvveti artırarak devam etmek.

SENARYO 31

Gömülü kanin traksiyona cevap vermiyor

Belirti: Traksiyon başladı; birkaç kontroldür klinik ve radyografik hareket yok.

OLASI NEDENLER

- Ankiloz.
- Traksiyon yönü yanlış; diş komşu köke doğru çekiliyor.
- Ataçman bağlantısı kopmuş.
- Kemik veya yumuşak doku engeli.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Seri radyografide konum değişimi
- [ ] Traksiyon yönü
- [ ] Bağlantının sağlamlığı
- [ ] Komşu köklerle ilişki

NE YAPMALI

1. Bağlantıyı kontrol edin.
2. Traksiyon yönünü komşu köklerden uzaklaşacak şekilde yeniden planlayın.
3. Kuvveti artırmayın.
4. Hareket yoksa ileri görüntüleme ile konumu ve ankiloz şüphesini değerlendirin.

Ne zaman yönlendirmeli: Ankiloz şüphesi, kök rezorpsiyonu veya cerrahi yeniden açma ihtiyacında ağız, diş ve çene cerrahisi ile ortak karar.

SENARYO 32 Traksiyon sırasında komşu kesicide mobilite

Belirti: Gömülü kanin çekilirken yan kesici hassas ve hareketli.

OLASI NEDENLER

- Kanin komşu kesici köküne temas ediyor.
- Komşu kökte rezorpsiyon başlamış olabilir.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Komşu dişin mobilitesi ve hassasiyeti
- [ ] Radyografide kök ilişkisi

NE YAPMALI

1. Traksiyonu geçici olarak durdurun.
2. Kök ilişkisini ileri görüntüleme ile değerlendirin.
3. Traksiyon yönünü yeniden planlayın.
4. Durumu kaydedin ve hastaya açıklayın.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Kök rezorpsiyonu şüphesinde ağız, diş ve çene cerrahisi ve deneyimli bir ortodontistle ortak değerlendirme.

SENARYO 33 Yer açıldı ama premolar veya ikinci molar sürmüyor

Belirti: Gerekli yer var; beklenen dönemde diş sürmedi.

OLASI NEDENLER

- Sürme engeli: kemik, yumuşak doku, süt dişi kökü.
- Primer sürme bozukluğu.
- Ankiloz.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Radyografik konum ve kök gelişimi
- [ ] Süt dişi kalıntısı
- [ ] Karşı taraf ile karşılaştırma

NE YAPMALI

1. Engeli belirleyin.
2. Süt dişi kalıntısı varsa çekimi değerlendirin.
3. Belirli bir süre izleme planlayın ve kaydedin.
4. İlerleme yoksa cerrahi değerlendirme isteyin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Sürme engeli veya primer sürme bozukluğu şüphesinde ağız, diş ve çene cerrahisi; çocuk hastalarda pedodonti görüşü.

SENARYO 34

Traksiyonla inen dişte dişeti problemi

Belirti: Diş arkta yerine oturdu ama dişeti dar, iltihaplı veya ataçman bağlantısı sürekli kopuyor.

OLASI NEDENLER

- Cerrahi açma tekniği dişeti için uygun değil.
- Hijyen yetersiz.
- Bağlantı tekrar tekrar kopuyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Yapışık dişeti genişliği
- [ ] Plak ve kanama
- [ ] Bağlantının durumu

NE YAPMALI

1. Hijyeni güçlendirin ve kaydedin.
2. Bağlantıyı yenileyin.
3. Dişeti durumunu belgeleyin.
4. Kalıcı dişeti problemi için yönlendirme kararını verin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Yapışık dişeti yetersizliği veya iyileşmeyen iltihapta periodontoloji.

BÖLÜM 09

Kök rezorpsiyonu şüphesi

Kontrol radyografisinde kök kısalması, artan mobilite veya travmalı dişte değişiklik.

Kök rezorpsiyonu şüphesinde paniğe değil, sisteme ihtiyacınız var: karşılaştırma, kayıt, kuvvet kontrolü ve gerekirse ara.

Sık hata

Başlangıç radyografisiyle karşılaştırmadan karar vermek.

SENARYO 35

Kontrol panoramiğinde kesici kökleri kısa görünüyor

Belirti: Ara kontrol panoramiğinde üst kesici kökleri başlangıca göre kısa.

OLASI NEDENLER

- Gerçek apikal rezorpsiyon.
- Projeksiyon farkı; panoramik görüntüde distorsiyon.
- Uzun tedavi süresi, büyük kök hareketi.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Başlangıç radyografisi ile aynı teknikte karşılaştırma
- [ ] Mobilite
- [ ] Travma öyküsü
- [ ] Tedavide yapılan kök hareketi

NE YAPMALI

1. Aynı teknikte karşılaştırmalı görüntü alın.
2. Gerçek rezorpsiyon varsa kuvvetleri azaltın ve gerekiyorsa aktif tedaviye ara verin.
3. Hedefleri yeniden değerlendirin; kalan hareketi azaltın.
4. Hastaya durumu açıklayın ve kaydedin.
5. Kontrol görüntüleme aralığını planlayın.

Ne zaman yönlendirmeli: Belirgin veya ilerleyen rezorpsiyonda deneyimli bir ortodontist ve endodonti görüşü alın.

SENARYO 36 Tedavi sırasında dişte mobilite arttı

Belirti: Bir veya birkaç dişte beklenenden fazla hareketlilik.

OLASI NEDENLER

- Oklüzal travma (erken temas).
- Periodontal iltihap.
- Kök rezorpsiyonu.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Erken temas
- [ ] Sondalama derinliği ve kanama
- [ ] Radyografide kök ve kemik

NE YAPMALI

1. Erken teması giderin.
2. Periodontal durumu değerlendirin.
3. Radyografi ile kökü kontrol edin.
4. Kuvvetleri azaltın ve izleyin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Periodontal yıkım bulgusunda periodontoloji; rezorpsiyon şüphesinde endodonti görüşü.

SENARYO 37 Travma öyküsü olan dişte renk değişikliği veya hassasiyet

Belirti: Daha önce darbe almış dişte renk koyulaşması, perküsyon hassasiyeti.

OLASI NEDENLER

- Pulpa canlılığını kaybediyor.
- Eski travmanın geç bulgusu.
- Ortodontik kuvvet travmalı dişte stres yaratıyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Canlılık testleri
- [ ] Perküsyon ve palpasyon
- [ ] Radyografide periapikal bölge ve kök

NE YAPMALI

1. Bu dişe uygulanan kuvveti azaltın.
2. Canlılığı belgeleyin.
3. Endodonti görüşü alın ve tedavi kararını birlikte verin.
4. Kararı ve süreci kaydedin (Rehber 4 · Travma ve Ankiloz).

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Canlılık kaybı veya periapikal bulguda endodonti; ankiloz şüphesinde uzman görüşü.

BÖLÜM 10

Elastik uyumsuzluğu

Hasta elastik takmıyor, yanlış takıyor, bırakıyor ya da randevuları kaçırıyor.

Uyum sorunu mekanik bir sorun değildir; iletişim sorunudur. Talimatı basit, yazılı ve ölçülebilir verin.

Sık hata

Uyumsuzluğu fark edip mekaniği değiştirmek ama hastayla açık konuşmamak.

SENARYO 38

Hasta elastik takmıyor

Belirti: Elastik paketi neredeyse dolu, kancalarda aşınma yok, ilerleme yok.

OLASI NEDENLER

- Talimat anlaşılmamış.
- Elastik takmak zor veya ağrılı.
- Motivasyon yok; hasta amacı bilmiyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Hastaya elastiği önünüzde taktırın
- [ ] Ağrı veya yara var mı?
- [ ] Hasta neden takmadığını kendi sözleriyle anlatsın

NE YAPMALI

1. Elastiği önünüzde bir kez taktırın.
2. Amacı bir cümleyle açıklayın: “Bu elastikler dişlerinizin kapanışını düzeltiyor.”
3. Basit yazılı bir takvim verin ve bir sonraki kontrolde birlikte bakın.
4. Çocuk hastada aileyi de dahil edin.
5. Uyum yoksa planın bu yüzden uzayacağını açıkça ve kaydederek söyleyin.

Ne zaman yönlendirmeli: Uyum ilerlemiyorsa uyuma daha az bağımlı mekanik seçeneklerini deneyimli bir ortodontistle değerlendirin.

SENARYO 39 Elastikler takılıyor ama yanlış konfigürasyonda

Belirti: Hasta elastik takıyor ama kapanış beklenmeyen yönde değişiyor.

OLASI NEDENLER

- Elastik yanlış kancaya takılıyor.
- Sağ ve sol karıştırılıyor.
- Talimat kâğıdı yok.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Hastaya taktırarak konfigürasyonu kontrol edin
- [ ] Kapanıştaki değişim yönü

NE YAPMALI

1. Doğru takmayı önünüzde gösterin.
2. Basit bir çizimle yazılı talimat verin.
3. Bir sonraki kontrolde yeniden kontrol edin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Genellikle gerekmez; iletişimle çözülür.

SENARYO 40 Elastik sürekli kopuyor veya hasta ağrı nedeniyle bırakıyor

Belirti: Hasta elastiğin koptuğunu veya ağrı yaptığını söylüyor.

OLASI NEDENLER

- Elastik boyutu veya kuvveti uygun değil.
- Kanca keskin ve dokuya batıyor.
- Elastik değişim sıklığı bilinmiyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Kancaların durumu
- [ ] Yanak ve dudakta yara
- [ ] Hastanın değişim alışkanlığı

NE YAPMALI

1. Keskin kancayı düzeltin.
2. Elastik boyutunu ve kuvvetini gözden geçirin.
3. Değişim sıklığını yazılı verin.
4. İlk günlerdeki hassasiyetin normal olabileceğini açıklayın.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** İyileşmeyen yara varsa ilgili hekim değerlendirmesi.

SENARYO 41

Randevu kaçıran hasta: vakada kontrol kaybı

Belirti: Hasta birkaç randevu kaçırdı; zincir gevşemiş, braketler düşmüş, ilerleme durmuş.

OLASI NEDENLER

- Randevu planı hastaya uygun değil.
- Hasta tedavinin neden uzadığını bilmiyor.
- Kontrol aralığı uzayınca mekanik kontrolsüz kalıyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Son kontrolden bu yana ne değişti?
- [ ] Düşmüş braket ve aparey
- [ ] Hijyen

NE YAPMALI

1. Durumu kaydedin ve hastaya açıkça gösterin.
2. Mekaniği güvenli bir duruma getirin (pasif bağlama).
3. Gerçekçi bir randevu planı yapın.
4. Kaçırılan randevuların süreyi uzattığını yazılı not edin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Genellikle gerekmez; klinik iletişim ve randevu planı ile ele alınır.

BÖLÜM 11

Aparey sorunları

Genişletme, fonksiyonel ve ankraj apareylerinde beklenen etki yok, nüks var ya da aparey sorun çıkarıyor.

Aparey sorunu çoğu zaman üç yerden gelir: endikasyon, uyum ve aparey bütünlüğü. Her kontrolde üçünü de kontrol edin.

Sık hata

Apareyi ağızda görüp çalıştığını varsaymak; aktivasyonu ve etkisini ölçmemek.

SENARYO 42

RME sonrası beklenen genişleme yok

Belirti: Vida aktive edildi; orta diastema oluşmadı, molar arası mesafe az değişti.

OLASI NEDENLER

- Sütür olgunlaşmış; iskeletsel yanıt sınırlı.
- Vida düzenli aktive edilmemiş.
- Bantlar gevşemiş; aparey dişleri taşımıyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Aktivasyon kaydı
- [ ] Bantların oturması
- [ ] Oklüzal radyografi veya klinik orta diastema
- [ ] Hasta yaşı ve büyüme dönemi

NE YAPMALI

1. Aktivasyon kaydını hastayla birlikte kontrol edin.
2. Bantları ve simanı kontrol edin.
3. Dental ve iskeletsel yanıtı ayırın.
4. Yanıt yoksa ve sütür olgunsa planı yeniden değerlendirin.

Ne zaman yönlendirmeli: Erişkinde iskeletsel genişletme ihtiyacı varsa ek seçenekler için deneyimli bir ortodontist veya cerrahi ile ortak değerlendirme.

SENARYO 43 Genişletme sonrası transversal nüks

Belirti: Genişletme sonrası çapraz kapanış yeniden başlıyor.

OLASI NEDENLER

- Pekiştirme süresi yetersiz.
- Dental devrilme ile genişletilmiş; iskeletsel yanıt az.
- Dil konumu alçak.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Molar eğimleri
- [ ] Ark genişliği seri ölçümleri
- [ ] Dil pozisyonu

NE YAPMALI

1. Nüksü ölçün.
2. Pekiştirme apareyini yerleştirin veya süreyi uzatın.
3. Molar torkunu kontrol edin.
4. Ek genişletme gerekiyorsa nedeni belirleyip planlayın.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Solunum problemi şüphesinde kulak burun boğaz değerlendirmesi.

SENARYO 44 Hareketli fonksiyonel apareyi hasta takmıyor

Belirti: Apareyde aşınma izi yok; overjet değişmiyor.

OLASI NEDENLER

- Aparey rahatsız veya konuşmayı engelliyor.
- Hasta ve aile amacı bilmiyor.
- Takma süresi net değil.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Apareyin uyumu ve basınç noktaları
- [ ] Hastanın anlatımı
- [ ] Overjet seri ölçümleri

NE YAPMALI

1. Basınç noktalarını düzeltin.
2. Amacı ve kullanım süresini yazılı verin.
3. Aileyle birlikte basit bir takvim kurun.
4. Uyum yoksa sabit seçenekleri değerlendirin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Genellikle gerekmez; uyum devam etmezse deneyimli bir ortodontistle sabit alternatifleri konuşun.

SENARYO 45 Sabit fonksiyonel aparey tekrar tekrar gevşiyor veya kırılıyor

Belirti: Teleskopik veya sabit fonksiyonel aparey bağlantısı sık sık ayrılıyor.

OLASI NEDENLER

- Bağlantı noktası zayıf.
- Hasta ağzı çok açtığında aparey zorlanıyor.
- Ark telleri yeterince rijit değil.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Bağlantı noktaları
- [ ] Kırık parça
- [ ] Tel boyutu

NE YAPMALI

1. Bağlantıyı yenileyin ve noktayı güçlendirin.
2. Ağız açma hareketini kontrol edin; aşırı açılımda takılma var mı bakın.
3. Ark tellerinin rijitliğini değerlendirin.
4. Tekrarlayan kırılmayı kaydedin; deseni günlükte izleyin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Ağız açmada kısıtlılık veya TME ağrısı varsa TME değerlendirmesi.

SENARYO 46 Transpalatal bar veya Nance mukozaya gömülüyor

Belirti: Damak mukozasında iz, kızarıklık veya aparey dokuya gömülmüş.

OLASI NEDENLER

- Aparey damağa çok yakın.
- Molarlar hareket etti; aparey konumu değişti.
- Hijyen yetersiz.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Mukozada ülser ve iltihap
- [ ] Aparey ile damak arası mesafe
- [ ] Bant uyumu

NE YAPMALI

1. Apareyi dokudan uzaklaştırın veya çıkararak yenileyin.
2. Dokunun iyileşmesini izleyin.
3. Hijyen talimatını yenileyin.
4. Ankraj gerekiyorsa geçici çözümü planlayın.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** İyileşmeyen veya yayılan lezyon varsa ağız, diş ve çene cerrahisi veya ilgili uzman değerlendirmesi.

BÖLÜM 12

Şeffaf plak oturmuyor

Plaklar dişlere tam oturmuyor, ataçmanlar kopuyor ya da planlanan hareket gerçekleşmiyor.

Şeffaf plakta takılma önce oturma kontrolüyle başlar. Plak ile diş arasında boşluk varsa hareket kontrolden çıkmıştır.

Sık hata

Oturmayan plakla bir sonraki aşamaya geçmek.

SENARYO 47

Plak dişin üzerine tam oturmuyor

Belirti: Plak ile diş yüzeyi arasında boşluk; özellikle kesici kenarlarda veya ikinci molarda.

OLASI NEDENLER

- Plak yeterli süre kullanılmamış.
- Planlanan hareket biyolojik olarak gerçekleşmemiş.
- Ataçman kopmuş veya aşınmış.
- Kontakt noktaları sıkı.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Hangi dişte oturma yok?
- [ ] Ataçmanların durumu
- [ ] Günlük kullanım süresi
- [ ] Kontaktlar

NE YAPMALI

1. Bir önceki plağa dönmeyi veya aynı plakta beklemeyi değerlendirin.
2. Oturmayı kolaylaştıran tekniği hastaya gösterin.
3. Ataçmanı yenileyin.
4. Oturma sağlanmazsa yeni ölçü ve planlama ile yeniden planlayın.

Ne zaman yönlendirmeli: Genellikle gerekmez; planın yeniden yapılması ortodontik karardır.

SENARYO 48 Ataçman kopmuş veya aşınmış

Belirti: Bir veya birkaç dişte ataçman yok ya da şekli kaybolmuş.

OLASI NEDENLER

- Yapıştırma yüzeyi yetersiz hazırlanmış.
- Hasta plakları çıkarırken zorluyor.
- Sert gıda ile temas.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Hangi ataçmanlar kopmuş?
- [ ] Plağın oturması
- [ ] Hasta plakları nasıl çıkarıyor?

NE YAPMALI

1. Ataçmanı şablonla yeniden yapın.
2. Plak çıkarma tekniğini hastaya gösterin.
3. Oturmayı kontrol edin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Genellikle gerekmez.

SENARYO 49 Planlanan rotasyon veya ekstrüzyon gerçekleşmiyor

Belirti: Plan ile ağızdaki konum arasında fark büyüyor.

OLASI NEDENLER

- Plak bu hareket için yeterli tutuculuk sağlamıyor.
- Yuvarlak kesitli dişte rotasyon zor.
- Ataçman yok veya uygun değil.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Plan ile ağızdaki konum farkı
- [ ] Ataçman tasarımı
- [ ] Kullanım süresi

NE YAPMALI

1. Farkı kaydedin.
2. Ataçman veya yardımcı mekanik ekleyin.
3. Gerekirse kısa bir sabit mekanik aşaması planlayın.
4. Yeni planlama ile devam edin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Genellikle gerekmez; mekanik değişikliği ortodontik karardır.

SENARYO 50

Plak kullanım süresi düşük

Belirti: Hasta plakları gün içinde uzun süre çıkardığını söylüyor.

OLASI NEDENLER

- Hasta kurallarını bilmiyor.
- Plak rahatsız veya konuşmayı etkiliyor.
- Yemek alışkanlıkları.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Oturma kontrolü
- [ ] Hastanın gün akışı
- [ ] Plağın durumu

NE YAPMALI

1. Günlük kullanım hedefini yazılı verin.
2. Plağın rahatsızlık yapan kenarlarını düzeltin.
3. Uyumu her kontrolde kaydedin.
4. Uyum yoksa planın uzayacağını açıklayın.

Ne zaman yönlendirmeli: Genellikle gerekmez.

BÖLÜM 13

Bitirmede kontaktlar ve kökler

Tedavi bitmek üzere ama kontaktlar açık, kökler paralel değil ya da oklüzyon oturmuyor.

Bitirmede sorun gidermek, tedavinin geri kalanından daha fazla dikkat ister. Braketleri sökmeden önce kontrol listesini tamamlayın.

Sık hata

Panoramik kontrol yapmadan braketleri sökmek.

SENARYO 51

Kontaktlar açık kalıyor

Belirti: Ön veya yan dişler arasında küçük boşluklar kalmış.

OLASI NEDENLER

- Bolton uyumsuzluğu.
- Kök paralelliği yok.
- Boşluk kapama sonrası pasif bağlama yapılmamış.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Bolton analizi
- [ ] Panoramikte kök angulasyonları
- [ ] Kontakt noktaları

NE YAPMALI

1. Kontaktları kapatın ve pasif bağlayın.
2. Diş boyutu uyumsuzluğu varsa restoratif seçeneği planlayın.
3. Kök paralelliğini kontrol edin.
4. Pekiştirme planına bu bölgeyi ekleyin.

Ne zaman yönlendirmeli: Küçük dişlerin şekillendirilmesi gerekiyorsa restoratif diş tedavisi.

SENARYO 52 Panoramikte kök paralelliği yok

Belirti: Kuronlar düzgün görünüyor; panoramikte kökler birbirine yaklaşmış veya ayrılmış.

OLASI NEDENLER

- Braket angulasyonu hatalı.
- Çekim bölgesinde kökler paralel kapanmamış.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Bitirme öncesi panoramik
- [ ] Braket konumları

NE YAPMALI

1. Braketleri yeniden konumlayın.
2. Kök hareketine zaman tanıyın.
3. Sökmeden önce kontrol görüntüsü alın.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Genellikle gerekmez; ortodontik bitirme kararıdır.

SENARYO 53 Marjinal sırtlar seviyede değil

Belirti: Komşu dişlerin marjinal sırtları arasında belirgin yükseklik farkı.

OLASI NEDENLER

- Braket yükseklik hatası.
- Diş kron şekli farklı.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Marjinal sırt seviyeleri
- [ ] Braket yükseklikleri
- [ ] Kron şekli

NE YAPMALI

1. Braket yüksekliğini düzeltin.
2. Tel üzerinde küçük bükümleri değerlendirin.
3. Kron şekli farklıysa seviyelemeyi buna göre yapın.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Kron şekli anomalisi varsa restoratif diş tedavisi.

SENARYO 54

Posterior oklüzyon oturmuyor

Belirti: Arka dişlerde tüberkül-fossa ilişkisi tam değil; temas noktaları az.

OLASI NEDENLER

- Rijit tel dişlerin oturmasına izin vermiyor.
- Tork farklılıkları.
- Erken temas.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Temas noktaları
- [ ] Molar ve premolar torku
- [ ] Erken temas

NE YAPMALI

1. Oturtma aşaması planlayın.
2. Gerekirse hafif oturtma elastikleri değerlendirin.
3. Erken temasları kontrol edin.
4. Oturmayı kaydedin ve pekiştirmeye geçin.

Ne zaman yönlendirmeli: Oklüzal TME semptomu varsa ilgili uzman değerlendirmesi.

BÖLÜM 14

Transversal problemler

Çapraz kapanış veya makaslama kapanış düzelmiyor; ark aşırı genişliyor.

Transversal problemi iskeletsel ve dental olarak ayırın. Ayırmadan yapılan genişletme ya nükseder ya periodontal sınırı zorlar.

Sık hata

Sadece dişleri devirerek transversal problem çözmek.

SENARYO 55

Posterior çapraz kapanış düzelmiyor

Belirti: Genişletme veya mekanik uygulandı; çapraz kapanış devam ediyor.

OLASI NEDENLER

- Problem iskeletsel; dental mekanik yetersiz.
- Fonksiyonel kayma var.
- Molarlar bukkale devrildi ama iskelet değişmedi.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Sentrik ilişkide çapraz kapanış
- [ ] Molar eğimleri
- [ ] Maksiller genişlik

NE YAPMALI

1. Fonksiyonel kayma var mı belirleyin.
2. İskeletsel ve dental bileşeni ayırın.
3. Dental devrilmeyi sınırlayın.
4. Gerekirse iskeletsel genişletmeyi planlayın.

Ne zaman yönlendirmeli: Erişkinde iskeletsel darlık varsa deneyimli bir ortodontist veya cerrahi ile ortak değerlendirme.

SENARYO 56 Makaslama kapanış düzelmiyor

Belirti: Üst premolar veya molar alt dişin bukkalinde; düzeltme ilerlemiyor.

OLASI NEDENLER

- Kapanış teması hareketi engelliyor.
- Mekanik tek arkta.
- Ankraj yetersiz.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Kapanış teması
- [ ] Hangi diş hangi yönde hareket etmeli?

NE YAPMALI

1. Geçici ısırma yükseltmesi ile teması kaldırın.
2. Gerekiyorsa her iki arkta mekanik planlayın.
3. Ankrajı değerlendirin.
4. İlerlemeyi kaydedin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Genellikle gerekmez; mekanik karardır.

SENARYO 57 Seviyelemede ark genişliği aşırı arttı

Belirti: Çapraşıklık çözülürken ark genişliği ve kanin arası mesafe arttı.

OLASI NEDENLER

- Yer ihtiyacı genişletmeyle karşılandı.
- Ark teli formu hastanın ark formuna uymuyor.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Kanin arası ve molar arası mesafe
- [ ] Başlangıç ark formu
- [ ] Bukkal dişeti

NE YAPMALI

1. Ark formunu başlangıç formuna göre seçin.
2. Yer ihtiyacını yeniden hesaplayın.
3. IPR veya çekim seçeneğini yeniden değerlendirin.
4. Bukkal dişeti değişimini izleyin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Bukkal dişeti çekilmesi başladıysa periodontoloji.

BÖLÜM 15

Periodontal ve hijyen sorunları

Beyaz lezyon, dişeti büyümesi veya dişeti çekilmesi tedaviyi riske atıyor.

Dokular sağlıklı değilse diş hareketi riskli hâle gelir. Hijyen bir hasta sorunu değil, tedavinin bir parçasıdır.

Sık hata

Hijyen problemini kaydetmeden ve hastaya göstermeden mekaniğe devam etmek.

SENARYO 58

Braket çevresinde beyaz lezyon başladı

Belirti: Braket çevresinde mat, beyaz demineralizasyon alanları.

OLASI NEDENLER

- Yetersiz fırçalama.
- Şekerli gıda ve içecek alışkanlığı.
- Braket çevresinde fazla adeziv.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Lezyonların yeri ve sayısı
- [ ] Plak indeksi
- [ ] Beslenme alışkanlığı

NE YAPMALI

1. Lezyonları fotoğrafla veya şemayla kaydedin.
2. Hastaya aynada gösterin ve fırçalama tekniğini yeniden öğretin.
3. Koruyucu uygulamalar için ilgili hekimle plan yapın.
4. Kontrol aralığında hijyeni izleyin.
5. Hijyen düzelmezse tedavinin devamını hastayla açıkça konuşun.

Ne zaman yönlendirmeli: Kavitasyon veya aktif çürük varsa restoratif diş tedavisi.

SENARYO 59 Dişeti büyümesi mekaniği engelliyor

Belirti: Dişeti braketleri ve zinciri örtüyor; boşluk kapama yavaşlıyor.

OLASI NEDENLER

- Plak birikimi.
- Bant veya zincir çevresinde iritasyon.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Kanama ve büyüme
- [ ] Plak
- [ ] Etkilenen bölgeler

NE YAPMALI

1. Hijyeni güçlendirin.
2. İlgili hekimle profesyonel temizlik planlayın.
3. İritasyon kaynaklarını kontrol edin.
4. Büyüme sürüyorsa yönlendirin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Hijyenle düzelmeyen dişeti büyümesinde periodontoloji.

SENARYO 60 Alt kesici labialinde dişeti çekilmesi başladı

Belirti: Alt ön dişlerin labial yüzünde dişeti seviyesi aşağı inmiş.

OLASI NEDENLER

- Kesicilerin labiale hareketi.
- İnce dişeti biyotipi.
- Sert fırçalama.

KONTROL EDİLECEKLER

- [ ] Dişeti seviyesi ve yapışık dişeti
- [ ] IMPA
- [ ] Fırçalama tekniği

NE YAPMALI

1. Durumu ölçün ve kaydedin.
2. Kesici proklinasyonunu sınırlayın.
3. Fırçalama tekniğini düzeltin.
4. Periodontoloji görüşü alın ve kararı birlikte verin.

> **Ne zaman yönlendirmeli:** Dişeti çekilmesi ilerlerse veya yapışık dişeti yetersizse periodontoloji.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi **Mekanik Sorun Giderme Atlası**'nı açın: buradaki senaryoların arkasındaki mekanik nedenleri konu konu tablolarda bulacaksınız. Her takılan vakayı **Vaka Günlüğü** ile kaydedin ve planı yeniden kurmak için **Modül 03 Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe** bölümüne dönün.